

HIV · diagnóstico, profilaxias e IRIS

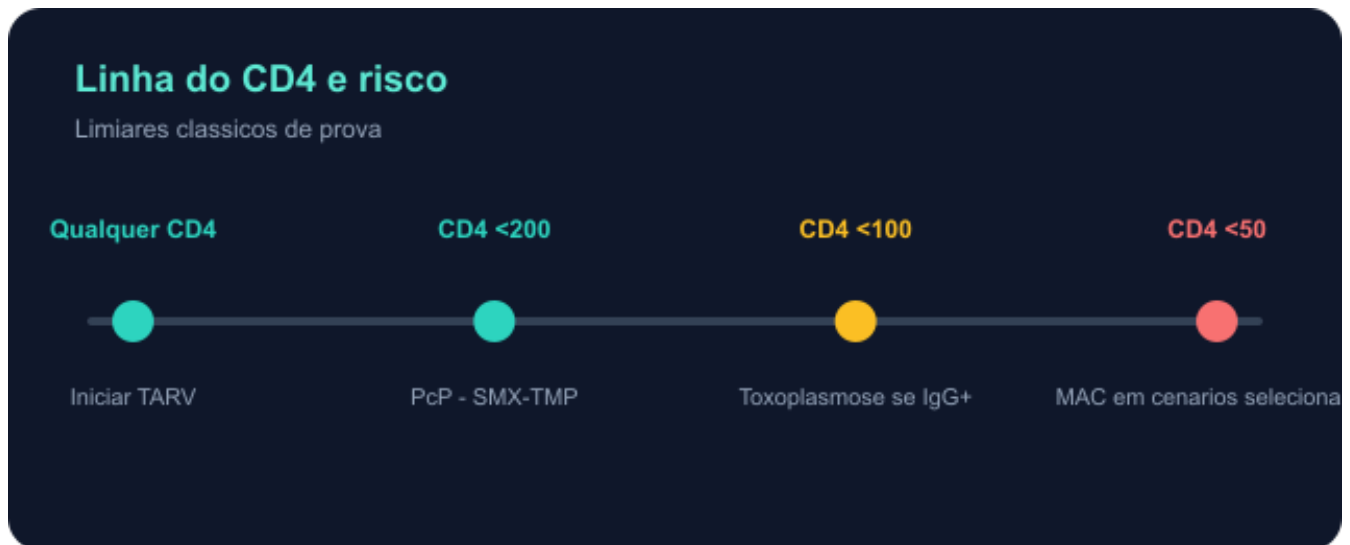
Todo paciente com HIV deve iniciar TARV o mais cedo possível. Use CD4 e clínica para decidir profilaxias e investigar oportunistas antes de atribuir tudo a 'efeito da medicação'.

Diagnóstico

Lembre - Diagnóstico

Triagem com teste rápido/4ª geração e confirmação conforme fluxo. Em infecção aguda, carga viral pode fechar diagnóstico quando sorologia ainda é negativa/indeterminada.

Memorize limiares: quanto menor o CD4, maior o espectro de oportunistas e necessidade de profilaxia.



Oportunistas high-yield

- PcP: dispneia + hipoxemia + LDH!; SMX-TMP ± corticoide se PaO₂ baixa
- Neurotoxoplasmose: múltiplas lesões anelares; tratar empírico se alta probabilidade
- Criptococose: cefaleia/meningite subaguda; latência de TARV após início do tratamento
- TB: sempre pensar; iniciar tratamento da TB e TARV com timing conforme meningite/CD4

Profilaxias clássicas

Condição | Profilaxia

PcP (CD4 <200) | SMX-TMP

Toxoplasmose (CD4 <100 + IgG+) | SMX-TMP

Exposição sexual de risco | PEP o mais cedo ("d72 h)

Parceiro sorodiscordante / risco contínuo | PrEP (seguir protocolo)

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

IRIS: piora paradoxal após início da TARV com recuperação imune. Não suspenda TARV rotineiramente — trate o oportunista e suporte; exceções raras (ex.: criptococose grave do SNC) seguem protocolo específico de timing.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Crítérios de AIDS e limiares de CD4 para infecções oportunistas clássicas são favoritos de prova.

Associar contagem de CD4 à infecção oportunista típica.

CD4 e oportunistas clássicas

Limites de prova

CD4 < 200: Pneumocystis (PCP)	<200
CD4 < 100: Toxoplasmose cerebral	<100
CD4 < 50: CMV, MAC, criptococo	<50
Qualquer CD4: TB, Candida oral	var

Profilaxia: PCP <200 | Toxo <100 IgG+ | MAC <50 (cenários)

AIDS = CD4 < 200 ou condição definidora de AIDS, independentemente do CD4.

Definição AIDS (ideia)

CDC / prova

- 1 CD4 < 200 cel/mm³
- 2 Ou doença definidora (PCP, Toxo, Cripto, Sarcoma Kaposi...)
- 3 Candidíase esofágica / TVP cerebral etc.

TARV para todos; urgência se oportunista / gestação / aguda

Profilaxias clássicas

Condição | Quando | Droga típica

PCP | CD4 < 200 | SMX-TMP

Toxo | CD4 < 100 + IgG+ | SMX-TMP

MAC | CD4 < 50 (se sem TARV imediata) | Azitromicina

Condutas de prova

- Iniciar TARV em todos os HIV+ (ideal precoce)
- IRIS: piora paradoxal após TARV — não suspender de rotina
- TB/HIV: tratar TB e iniciar TARV em semanas (mais cedo se CD4 muito baixo)
- Criptococose meníngea: anfotericina B ± flucitosina ! fluconazol; atrasar TARV ~5 semanas

Diagnóstico

Lembre - Diagnóstico

Triagem com teste rápido/Ag-Ac 4ª geração; confirmar. Carga viral e CD4 para seguimento.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1